ULM 14.04.2026 Kenntnisprüfung (KP) – Prüfungsprotokoll

2/3 haben bestanden. Der 4 Kandidat weiß ich nicht

Prüfer

- Vorsitzender: Dr. Lang – Unfallchirurg
- Internist: Dr. Keller – Nephrologe
- Anästhesiologe

Vorbereitung

- Dauer: ca. 4–5 Monate intensive Vorbereitung
- Materialien: Amboss, Pharma-Bücher, Last Minute, Mediknow, Videos (Apetizer Chirurgie), Simulationen mit Lernpartnern!! Und PROTOKOLLE!!!(die sind sehr wichtig! Viel wiederholt sich!)

Teil 1 – Arztbrief

- Thema: Hepatotoxizität durch Albendazol: sichere Alternativen bei Echinokokkosetherapie
- Zeit: 2 Stunden zum Schreiben eines Arztbriefs
- Um 11:00 Uhr sammelte der Vorsitzende die Briefe ein
- Reihenfolge der Abgabe bestimmte die Reihenfolge für Teil 2 und Teil 3

Teil 2 – Praktische Untersuchung

- Untersuchung an einer Schauspielpatientin (auch keine Puppe)
- Fallvorstellung mit Unterbrechung und Zwischenfragen zum Fall
- Themen:
  - Leberhautzeichen und klinische Untersuchung
  - Häufige Frakturen im Alter der „Patientin"?: sie war ca. 60 Jahre (ich habe distale Radiusfraktur genannt und kamen dann Fragen dazu. Untersuchung, nennen welche Bewegungen im Handgelenk: Abduktion, Adduktion, Flexion, Extension)
  - Sichere und unsichere Frakturzeichen: nennen und zeigen
  - Palpation kleiner Handknochen, zeigen wo ist Os scaphoideum (Kahnbein) (auch Tabatière genannt dieser Bereich)

- Erste Hilfe nach Sturz nach der Blutspende, 4 Treppen runtergefallen (ABCDE, Bodycheck): alles zeigen und gleichzeitig erklären
- Weitere Themen bei anderen Prüflingen: neurologische Untersuchung, Abdomen-, Lungenuntersuchung, Milzuntersuchung, rheumatoide Arthritis usw.

Teil 3 – Theoretischer Teil

Internist:

- Hauptfall – Bericht aus Teil 1: Echinokokkose der Leber unter Albendazol (fast alle Fragen von ihm bezüglich diesen Fall)
- Fragen zu:

- Leberschädigungen: welche gibt es (toxisch, autoimmun usw.), welche bei diesem Patient aus Artikel
- Therapie
- Darf man diese Zyste punktieren? nein
- Differenzierung Zyste vs Tumor im Sono usw.
- danach Bilddiagnostik: Auf Bild war Fotos von Patienten und rechts 5/6 mögliche Diagnosen auf Englisch. Ich musste auswählen welche richtig ist. Ich wusste aber nicht alle und dann durch Ausschließen gemacht („diese Diagnose passt nicht und warum“). Wenn ich irgendwas nicht wusste, war es nicht schlimm.

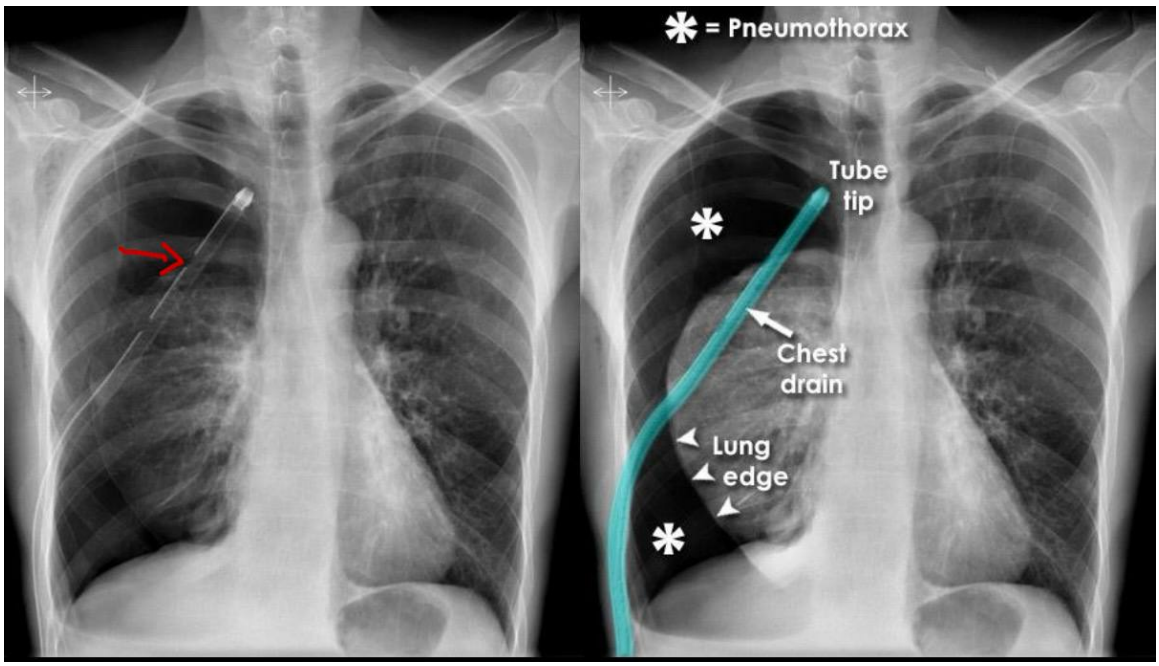
Bildfälle

1. Adult-onset Still's disease (27-jährige Frau mit Fieber, Polyarthritis, Hautausschlag)
2. Scharlach (hier auch Fragen was das ist)
3. Masern bei Erwachsenen

Dann Unfallchirurg

Röntgen Thorax: Pneumothorax (Beschreibung und Therapie), das war kein Spannungspneumothorax, man muss sagen warum.

Danach zweites Bild mit Drainage: was ist weise Linie hier? (Scapula). Was ist weise Linie entlang der Drainage und warum mit Unterbrechung? : röntgendichte Markierung (Radiopakstreifen. Unterbrechung der weißen Linie zeigt die Position des letzten Seitenlochs der Drainage)



Postoperatives Fieber

- Patient 4 Tage nach Sigmaresektion
- Alle Ursachen Postoperatives Fieber?: Wundinfektion, Pneumonie, Harnwegsinfektion, **Anastomoseninsuffizienz!**, Katheterinfektion, Thrombose, Abszess usw.

- dann Frage: wenn es Anastomoseninsuffizienz wäre, was hat der Patient noch (Peritonitis). Wie man das nur mit Händen bestätigt?
- ZVK-Infektion (Rötung an der Stichstelle): Katheter entfernen? Oder lassen? Welche Reihefolge? – zuerst entfernen, dann Kulturabnahmen, dann Antibiotika; Katheterspitze einschicken (nicht den ganzen Katheter!!),

Dann Anästhesiologe

Reanimation

- Bewusstloser Patient auf Straße. Was machst du?
- Reanimationsalgorithmus im Krankenhaus! KOMPLETT jeder Schritt mit Dosierungen von Adrenalin und Amiodaron
- Defibrillierbare und nicht-defibrillierbare Rhythmen

- Was mach ich als Teamleiter während Reanimation? Was muss ich beachten?
- Ursachen nach 4H und HITS: nennen und kurz Behandlung zu jedem

- Wenn es LAE wäre, was dann? Lyse. Wenn Lyse durchgeführt wurde, wie lange muss man weiter reanimieren (60 bis 80 Minuten)

Eindruck

- Prüfer waren freundlich und hilfsbereit
- Fragen waren klassisch und nicht zu tiefgehend
- Simulationstraining war sehr hilfreich!

Viel Erfolg an alle!